Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Nova Alvorada do Sul
Vara Única

Autos: n. 0800976-93.2023.8.12.0054
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor: Jhonatan Pereira da Silva Benites
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada em caráter de urgência proposta por Jhonatan Pereira da Silva Benites em face do Município de Nova Alvorada do Sul/MS e Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra o requerente que é portador de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10: F90), razão pelo qual necessita dos medicamentos Attenze/Ritalina/Medato 10MG. Sustentou que é obrigação dos requeridos o fornecimento dos medicamentos que necessita, pois não tem condições financeiras para sua aquisição. Requereu, portanto, em tutela de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam os medicamentos pleiteados. Ao final, requereu a procedência dos pedidos e concessão do benefício da gratuidade da justiça. Juntou documentos (p. 13-23).

Sobreveio o parecer do NAT desfavorável a concessão dos medicamentos (p. 25-33).

Foi indeferido a concessão da tutela de urgência (p. 34-38).

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às p. 48-62, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no presente feito (Tema nº 793 de Repercussão Geral). No mérito, aduziu que não estão presentes no caso em voga os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ. Subsidiariamente, requereu a não fixação de multa diária em caso de descumprimento, afirmando a impossibilidade de fixação de astreintes.

O requerente informou a interposição de agravo de instrumento (p. 64).

A tutela recursal foi indeferida nos autos do agravo n.º 1423116-40.2023.8.12.0000 (p. 100-120).

Devidamente citado, o Município de Nova Alvorada do Sul/MS apresentou contestação (p. 72-81), alegando como preliminar, ***(i)*** sua ilegitimidade passiva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

ad causam, ao argumento de que a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos do SUS é de competência da União e, ***(ii)*** o redirecionamento da responsabilidade de fornecimento para o Estado, pelo fato do ente conseguir suportar o ônus financeiro. No mérito, suscitou que o pedido do requerente não preenche os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, ante a ausência de provas da incapacidade financeira, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS.

O requerente apresentou impugnação a contestação (p. 83-89).

As partes requereram o julgamento antecipado de mérito (p. 95, 97 e 99).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. **Decido.**

II - Fundamentos

2.1. Do julgamento antecipado de mérito

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, prescindindo, portanto, de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.2. Das preliminares

I - Em relação a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no polo da ação (Tema nº 793 de Repercussão Geral), destaco que a tese de repercussão geral fixada a respeito do tema 793, ficou redigida nos seguintes termos: ***Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,*** *e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Em 25/05/2019, ela foi aprimorada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que o Min. Edson Fachin, que proferiu o voto condutor do acórdão, esclareceu o entendimento atual da Suprema Corte. Veja-se a ementa:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.* ***1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.* ***3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.*** *Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.*
> (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Depreende-se, portanto, que a União somente deverá necessariamente integrar o polo passivo das ações que exijam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, sendo que, nos demais casos, prevalece o posicionamento quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, o que evidentemente não se aplica ao caso em tela.

Dito isso, rejeito tal preliminar.

II - A preliminar apresentada pelo Município de Nova Alvorada do Sul/MS (***ilegitimidade passiva ad causam***), referente à ausência de responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico postulado, onde um atribui a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso do Sul, confunde-se com o mérito da causa, portanto, com ele será analisado. Ocorre que a discussão sobre a competência para a disponibilização do tratamento médico vindicado é questão de mérito, não guardando relação com os pressupostos processuais ou com as condições da ação.

Assim, a legitimidade passiva está presente, já que o requerente apresenta em sua causa de pedir a alegação de que os requeridos possuem a incumbência legal de lhe disponibilizar tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde.

2.2. Do mérito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

No mérito, a pretensão do requerente é improcedente.

Toda pessoa tem direito ao adequado tratamento de saúde, decorrente do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido à categoria de fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1.º, inc. III, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, o art. 5º, caput, da Constituição Federal discorre que: *"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade"*.

Sendo decorrência do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a saúde é um direito fundamental do cidadão, e, como tal, tem a característica de vincular o Poder Público à sua estrita observância.

Além de configurar-se como direito fundamental e, portanto, de observância obrigatória pelo Estado, a própria Constituição Federal disciplina que a saúde é direito de todos e, conforme dito anteriormente, dever do Estado prestá-la, como se depreende do art. 196, a seguir transcrito: "*CF. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Com efeito, nada obstante a saúde seja reconhecida como direito de todos e dever do Estado, é certo que tal direito fundamental, consistente na assistência à saúde, individual ou coletiva, e em qualquer grau de complexidade, não é absoluto. Isso ocorre porque os recursos públicos são escassos e as demandas crescem em progressão geométrica, de modo que tal assistência pelo Estado deve ser propiciada nos limites das possibilidades do Poder Público, em razão da comprovada deficiência financeira que assola a maioria dos entes estatais.

Em complemento, destaco o entendimento exarado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento conjunto dos recursos n.º 566.471-RS e 657.718-MG, os quais tiveram repercussão geral reconhecida, cujo trecho na parte que interessa a seguir traslada-se:

Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

> *remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiros devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamento não incluído na política pública.*

Nesse passo, não se nega a possibilidade de se reivindicar do Estado o medicamento pretendido. Entretanto, não se pode desconsiderar que o oferecimento de tais fármacos, de modo irrestrito e desprovido de qualquer critério, sobrecarregaria em demasia o sistema de saúde brasileiro, o qual já se encontra em manifesto declínio.

Dessarte, deve o Poder Judiciário atuar com cautela e estabelecer parâmetros práticos para a sua concessão, cuja aferição deve se dar em cada caso concreto, com o propósito de enjeitar as hipóteses em que prescindível a atuação do Estado.

Através da análise de dos julgados proferidos pelos tribunais pátrios, que envolvem a concessão de medicamento, tratamento e equipamento àqueles que buscam tal prestação, é possível estabelecer certos critérios para um melhor exame do provimento jurisdicional pleiteado.

Por primeiro, elenca-se que a destinação dos recursos públicos devem ser dirigidos àquelas pessoas que não dispõem de condições para a aquisição, por conta própria, de medicamento/tratamento, sob pena de subverter-se o propósito do direito pleiteado.

Já o segundo corresponde à essencialidade de laudo médico que corrobore a imprescindibilidade do medicamento ou tratamento prescrito ao paciente, de modo que a sua não utilização ou substituição por outro semelhante traduza em uma piora no quadro de saúde do enfermo.

Por último, mas não menos importante, necessário se mostra a efetiva comprovação do benefício à saúde do paciente, com a consequente melhora de seu estado clínico, com a finalidade de se afastar tratamentos experimentais, os quais se encontram em fase de teste, cuja eficácia e segurança não se encontram presentes.

Fixadas tais premissas, há que averiguar se elas se encontram presentes no quadro litigioso.

À vista do primeiro requisito, entende-se que ele se encontra preenchido, já que o assistido não dispõe de condições financeiras para arcar com o custo do medicamentoso, tanto que fazia seus atendimentos pela rede pública de saúde (p. 14), além

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

de estar assistido processualmente pela Defensoria Pública do Estado.

Mas, igual sorte não lhe assiste quanto aos demais critérios. Examinando os autos, verifica-se que os laudos acostados aos autos não atestam que os medicamentos seriam de urgência ou risco no caso do requerente.

Pois bem. O laudo médico de p. 21-23 afirma genericamente que não há alternativa na rede pública para tratamento do problema de saúde do requerente, ao passo que o parecer do NAT indica tratamentos similares para a enfermidade, que são fornecidos pelo SUS (item "IX", fl. 32), vejamos:

> **IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;**
>
> A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária, com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). De acordo com a Portaria GM/nº 943 de 22/08/2000, os recursos financeiros federais destinados ao Programa de Aquisição de Medicamentos Essenciais para a Área de Saúde Mental, do Estado de Mato Grosso do Sul, são repassados aos Fundos Municipais de Saúde, dos municípios. Vale salientar que o CAPS é um serviço comunitário que foi criado com o intuito de cuidar de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos severos e persistentes, no seu território de abrangência. Devem obedecer a alguns princípios básicos dentre os quais se responsabilizarem pelo acolhimento de 100% da demanda dos portadores de transtornos severos de seu território.
>
> O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade − TDAH, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 14 de 29/07/2022, indica o tratamento preconizado pelo SUS (não há tratamento farmacológico).
>
> A RENAME 2022 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), antipsicóticos (Clorpromazina, Haloperidol), ansiolíticos (Clonazepam, Diazepam).

Ora, se o SUS disponibiliza outros meios para o tratamento do mesmo diagnóstico e inexiste nos autos prova de que aqueles substitutivos não seriam eficazes ao tratamento da moléstia suportada pelo autor, não parece legítimo obrigar o Poder Público a ofertar outros medicamentos se não aqueles disponibilizados na rede municipal de saúde.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados semelhantes ao caso posto proferidos pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA LÚPUS ERITEMATOSO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

SISTÊMICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REFORMADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAQUELES REGULARMENTE DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TESE DO STJ – TEMA 106. RECURSO PROVIDO. Não é razoável exigir do Poder Público medicamento específico, diverso daquele regularmente disponibilizado pelo SUS, especialmente não havendo comprovação da ineficácia deste último ou mesmo da imprescindibilidade da prescrição médica.
(**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 2000756-96.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 17/01/2023, p: 18/01/2023)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS GRATUITAMENTE FORNECIDOS PELO PODER PÚBLICO NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – REQUERENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. 1 - A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178- SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. 2 - Não se observa que o entendimento da Suprema Corte altere a ocorrência da solidariedade passiva, nem se traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidade da inclusão da União no pólo passivo da demanda. A solidariedade, por sua própria qualidade intrínseca, reflete na existência do litisconsórcio facultativo, pois ocorre "quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda" (art. 264/CC). Neste sentido, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça "segundo o qual, a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo." (AgRg no Resp 1164933/RJ). 3 - Em que pese a saúde ser direito de todos, consoante respaldo constitucional (arts. 23, II, e 196), a procedência de toda e qualquer ação fundada no tema, conforme vinha ocorrendo sob esse fundamento constitucional genérico e abstrato, terminava por produzir um verdadeiro caos no orçamento público, pois exigia a adoção de providências sem qualquer lastro de previsão financeira, impactando demasiadamente nos cofres públicos e na própria condução das demais políticas públicas, ante a manifesta escassez de recursos. 4 - Ademais, sendo a saúde espécie do gênero seguridade social, e o fornecimento de remédios uma das várias prestações deste, devem ser observados os princípios básicos que subsidiam o sistema da Seguridade, in casu, a seletividade (art. 194, par. ún., inc. III da Constituição Federal), princípio voltado ao legislador e ao administrador público, que devem eleger

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

> *quais contingências estão aptas ao resguardo pelo Poder Público, pautado no ideal de prestações que comportem a mais ampla proteção social possível, tendo sempre por norte a solidariedade como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º da Carta Magna). Nesta toada, interessante pontuar que quando conveniente, tanto legislador quanto o gestor público (claro que a este dentro da discricionariedade administrativa proporcionada pela norma), selecionam as prestações (medicamentos e procedimentos) devidos à população, como por exemplo, a distribuição de medicamentos para o combate do vírus HIV, direito subjetivo amparado pela Lei nº 9.313/96, ou os medicamentos distribuídos pelo SUS na rede pública de saúde. 5 -* ***Se há tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não há razão para o Judiciário interferir nas decisões legislativas e administrativas sobre a pretensa justificativa da existência do direito fundamental à vida e à saúde, afinal, as leis devem ser compreendidas dentro de um sistema interpretativo que promova a harmonia entre as normas que o compõem, sem interpretações isoladas e, no mais das vezes, desastrosas à implementação de políticas públicas. 6 - A flexibilização desse raciocínio pelo Judiciário só seria possível ante as peculiaridades do caso concreto, anotadas à situação urgente em que há o risco iminente à vida do paciente e a utilização anterior dos medicamentos ou demais procedimentos prestados pelo SUS, além de não tratar-se de tratamento experimental – pelo qual as incertezas de seus efeitos subsidiam a obstaculização de seu fornecimento pelo juiz, com amparo no princípio da precaução.*** *7 – Não tratando-se, in casu, de situação que excepciona a orientação firmada, a revogação da liminar concedida é medida que se impõe. 8 – Sendo o Ente Estadual sucumbente, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais se a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual, ante a confusão gerada na figura simultânea de credor e devedor do Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o art. 381 do CC. Orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos de sua Súmula nº 421. 9 - Reexame necessário e recurso de apelação dos Estado de Mato Grosso do Sul providos. Recurso da Defensoria Pública Estadual prejudicado.*
> (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0801303-16.2019.8.12.0042, Rio Verde de Mato Grosso, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2021, p: 21/09/2021) (grifei)

O direito à saúde, embora seja obrigação do Estado, não assegura de forma irrestrita o fornecimento do medicamento pretendido pelo paciente, sem caráter de urgência, preterindo outros que, melhores posicionados na lista de espera organizada pelo órgão de saúde, aguardam o mesmo procedimento, sob pena de ruptura do princípio da isonomia.

Em auxílio ao tema em discussão, oportuna a invocação do enunciado 16 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, realizado em 15/05/2014, em São Paulo/SP:

> *[...] "nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.

> *deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS".*

Assim, demonstrado que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, inc. I, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos autos pelo requerido e pelo Parecer Técnico do NAT, outra solução não resta senão a improcedência da demanda.

III - Dispositivo

Isso posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da lide e **julgo improcedente** o pedido formulado na inicial, em face do Município de Nova Alvorada do Sul/MS e Estado de Mato Grosso do Sul.

Sem custas e honorários.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Nova Alvorada do Sul, *datado e assinado digitalmente.*

Juliano Luiz Pereira
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 08/08/2024 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800976-93.2023.8.12.0054 e código gehhQVRh.